

Gizarte Politikaren Eskuliburua: Zahartze Aktiboa, Generoa eta Erantzukizun Bateratua

1. Esparru Kontzeptuala: Zahartzearen Paradigma Aldaketa

Biztanleriaren zahartzea ez da gizarte-patologia bat, ezta sistema publikoaren kolapso hurbil bat ere, baizik eta gure osasun eta ongizate politiken arrakasta handiena. Fenomeno honek babes pasiboko eredu batetik —non Estatuak ahultasunari laguntzen dion besterik gabe— autonomia aktiboaren paradigma batera aldatzea eskatzen du. Erronka estrategikoa adinekoak herritar oso eta eragile produktibo gisa integratzean datza, haien iraupena gizarte-garapenerako aukera bat dela aitortuz, eta ez zama fiskal bat soilik.

1.1. Zahartze Aktiboaren Definizioa eta Determinatzaileak

Osasunaren Mundu Erakundearen (OME) esparruan, zahartze aktiboa osasun, parte-hartze eta segurtasun aukerak optimizatzeko prozesu gisa definitzen da, bizi-kalitatea hobetzeko. Ezinbestekoa da administrazio publikoak kontzeptu hau ez ulertzea beranduko esku-hartze gisa, baizik eta bizi-ziklo osoa hartzen duen prebentzio-prozesu gisa. Zahartzearen determinatzaileak (biologikoak, portaerazkoak eta sozialak) haurtzarotik kudeatu behar dira "plastizitate kognitiboa" eta "positibotasun efektua" zahartzaroan baliabide funtzional gisa mantentzen direla ziurtatzeko.

1.2. Europako Esparrua eta Belaunaldien arteko Elkartasuna

Zahartze Aktiboaren eta Belaunaldien arteko Elkartasunaren Europako Urteak (2012) mugarri bat markatu zuen gizarte-kohesioan. Belaunaldien arteko lankidetza da egonkortasun modernoaren oinarria; ez da soilik transferentzia ekonomikoei buruzkoa, baizik eta ezagutzaren "transmisioaren etika" bati buruzkoa. Politika publikoak elkartasun hori babestu behar du gazteen eskubideak adinekoenekin alderatzen dituzten ikuspegi laburren aurka.

1.3. Eredu Berriaren Balioak

Politiken diseinu operatiboa ongizate-sistema zaharrenekin kontrastatzen diren hiru zutabeetan oinarritu behar da:

Autonomia Kritikoa: Norberaren bizitza-proiektuari buruzko erabaki informatuak hartzeko gaitasuna, mendekotasun-egoeretan ere.

Duintasuna: Erakundeetan tratu bidezkoa bermatzea, infantilizazioa eta tratu alboratzailea saihestuz.

Aniztasuna: Zahartzaroa heterogeneoa dela aitortzea. Zahartze modu ugari daude generoaren, sexu-orientazioaren, kulturaren eta etniaren arabera. Printzipio etiko hauek dira Espainiako errealitate demografiko konplexua kudeatzeko oinarria, adinaren berregituraketa aurrekaririk gabeko batek markatua.

2. Diagnostiko demografikoa: Zahartzaroaren feminizazioa

Zerbitzu publikoen plangintzak zorrotasun zientifikoa behar du, eragile demografikoetan oinarrituta: ugalkortasunaren beherakada, iraupen luzera handitzea eta migrazio-fluxuen migrazioa. Bektore hauek aztertuz bakarrik aurreikus ditzakegu adin-egitura alderantzikatu zaion gizarte baten eskaerak.

2.1. Biztanleriaren dinamika Espainiako

Espainiak adinaren arabera birmoldaketa bizkortu bat jasaten ari da. 1900-2049rako proiektzioen arabera, 65 urte edo gehiagoko biztanleria guztizkoaren % 35 ingurura iritsiko da 2049rako. Gizonezkoen hilkortasunaren hobekuntzaren ondorioz sexu-erlazioa apur bat orekatzeko joera badu ere, adinekoen zahartzea (80 urte eta gehiago) izango da XXI. mendeko joera nagusia, eta azpiegitura sozial eta sanitario masibo eta espezializatua beharko du.

2.2. Feminizazioaren Fenomenoa

Espainian, zahartzaroak aurpegi femeninoa du nagusiki. Emakumeek 65 urtetik gorako bizi-itxaropena dute, baina baita gaixotasun kronikoen eta ezgaitasunaren prebalentzia handiagoa ere. Bizi-iraupen handiagoak esan nahi du emakumeek bakardade eta mendekotasunaldi luzeagoak jasaten dituztela, eta horrek eragina du epe luzeko arreta zerbitzuen eta telelaguntza proaktiboaren eskarian.

2.3. Lurralde-desorekak

Erantzun publikoak bi errealitate geografiko desberdinetara egokitu behar du:

Landa Eremuak: Eremu hauek "gehiagizko zahartzea" jasaten dute gazteen emigrazioaren ondorioz. Hemen, zerbitzuen hornidura esponentzialki garestiagoa da biztanleriaren sakabanaketaren ondorioz, eta horrek arreta eredu mugikorrak behar ditu.

Hiri Eremuak: Zahartzea in situ gertatzen da. Erronka "hiri bakardadea" da hiri handietan, non isolamendua larriagoa izan daitekeen baliabideen hurbiltasun fisikoa izan arren. Emakumeen bizi-iraupenak eta biztanleriaren sakabanaketak markatutako profil demografiko honek bizikidetza modu berriak eta etxebizitza eredu alternatiboen beharra definitzen ditu.

3. Bizikidetza Eredu Berriak eta Autonomiaren Balioa

Familia tradizioaletik "familia bertikalera" igarotzeak (belaunaldi gehiago, baina kide gutxiago bakoitzean) laguntza-sare informala ahuldu du. Horrek gizarteak zaintza mantentzeko duen gaitasuna birpentsatzera behartzen gaitu.

3.1. Bakardadearen eta Egoitza Autonomiaren Sorrera

Pertsona bakarrek etxeen gorakadaren aurrean, batez ere alargun geratu diren emakumeen artean, "urruneko intimitatearen" kontzeptua sortu da. Mediterraneoko ereduaren ezaugarri bat da, non, Ipar Europan ez bezala, bakarrik bizitzaren autonomia nahiago den, familia-sarearekin "hurbiltasun-elkartasuna" mantenduz.

3.2. Bizitzeko Lehentasunak eta Etxebizitza Aukerak

Adineko pertsonen nahiak aho batezkoak dira: beren etxean geratzeko nahia da lehentasuna. | Egoitza Aukera | Lehentasuna (%) | Politika Publikoaren Ondorioak || ----- | ----- | ----- || Etxe Jabea | Oso Altua (>%80) | Telelaguntza eta etxeko laguntza lehenetsi. || Haurren Etxea | Gainbehera | "Ogitarteko belaunaldiaren" gaineko presioa murriztu. || Zaharren Egoitzak | Gutxiengoa | Mendekotasun handiko kasuetarako erreserba; ereduak eguneroko bizitza. || NC/Bestelakoak | Hondarrak | Aukera berriei buruz informatu beharra (etxebizitza partekatua). |

3.3. Belaunaldien arteko harremanak

Espainiako familien elkartasuna sendoa izaten jarraitzen du, baina erdiko belaunaldiaren zama gehiegizkoa dela eta kolapsatzeko arriskua du. Laguntza publikoa ezinbestekoa da, familiaren

laguntza maitasun ekintza bat izan dadin eta ez kanpoko baliabide faltak ezarritako betebeharrak. Benetako autonomia bizilekuaren aukeraketan behartutako instituzionalizazioa saihesteko laguntza zerbitzuak sartzen direnean bakarrik bermatzen da.

4. Zaintza Politika eta Gizarte Erantzukizun Partziala

Ongizatearen iraunkortasuna "familia elkartasunetik" (funtsean emakumezkoena) Estatua, merkatua eta hirugarren sektorea integratzen dituen gizarte erantzunkidetasunera igarotzearen mende dago.

4.1. Zaintza Informalaren Errealitatea

Espainian zaintzaile tipikoa oraindik emakumea da (alaba edo emaztea). Hala ere, lan merkatuan guztiz integratzeak eta genero rolen aldaketek "zero kostuko zaintza" eredu jasanezina bihurtzen dute. Gobernuak laguntza profesionalizatu behar du emakume hauek langile prekario bihurtu ez daitezen.

4.2. Zaintza-Immigrazio Lotura

Espainiako eredu berriaren ezaugarri nagusietako bat etxeko zaintzarako atzerriko langileen kontratazioa da. Hego Amerikako eta Marokoko emakumeak Espainiako ongizatearen zutabe berria bihurtu dira, mendekotasuna sektore pribatuan kudeatuz. Premiazkoa da sektore hau arautzea eta profesionalizatzea, zaintzaren kalitatea eta lan eskubideak bermatzeko.

4.3. Ongizate Zerbitzu Proaktiboak: Kontzientziazio-Erabilera Hutsunea

Zerbitzuen kontzientziaren eta haien benetako erabileraren artean hutsune kritikoa dago (30. irudiko datuen arabera):

Egoitza Zaintzeko Etxeak: % 92,2ko kontzientzia, baina erabilera oso baxua (% 0,8).

Telelaguntza: % 80,4ko kontzientzia, % 7,6ko erabilera.

Eguneko Zentroak: % 85,4ko kontzientzia, % 2,3ko erabilera. Gizarte politika proaktiboa izan behar da, mendekotasun krisi bat gertatu aurretik autonomia sustatzen duten zerbitzuetarako sarbidea erraztuz.

5. Dimentsio Ekonomikoa eta Gizarte Babesa

Zahartzearen ekonomiak erakusten du adineko helduak ez direla prestazioen hartzaile pasiboak.

Haien pentsioak kontsumoaren motor eta familien egonkortasun mekanismo gisa jokatzen dute krisi garaian.

5.1. Pentsio Sistema Segurtasunaren Zutabe gisa

27/2011 Legeak Gizarte Segurantzaren modernizatu zuen, nahikotasunaren eta elkartasunaren printzipioak indartuz. Ezinbestekoa da gutxieneko pentsioak eta alargun pentsioak babestea, adineko emakumeen bazterketaren aurkako oztopo nagusia baita.

5.2. Diru-sarreraren eta Pobreziaren Arriskuen Azterketa: Aktiboen Paradoxa

Analisi ekonomikoak "errenta egotziaren" kontzeptua integratu behar du. Espainiako adineko asko "aberatsak baina diru-txikiak" dira: etxebizitzak dituzte, baina ez dute diru-sarrera likido nahikorik. Horrek eskatzen du alderantzizko hipotekak edo bizitza osorako errentak bezalako mekanismoak aztertzea, aberastasun hori bizi-kalitate hobeto bihurtzeko.

5.3. Harreman Ekonomia eta Herriarren Ekonomia

Adinekoek balio sozial izugarria eta monetizatu gabea sortzen dute. Herritarren Ekonomiaren bidez, urtero milioika ordu eskaintzen dituzte bilobak zaintzeko (orduen % 56 beste etxe batzuei laguntzen ematen diete) eta komunitateko jardueretarako (erlijiosoak, auzokoak eta kulturalak). Kapital sozial honek belaunaldi gazteen lan-bizitza orekatzea eta hirugarren sektorearen bizitasuna ahalbidetzen ditu. Premiazkoa da benetako ekarpen ekonomiko hau ikusezin bihurtzen duten eta jarduera ezaren pertzepziora murrizten duten aurreiritziei aurre egitea.

6. Zaharreriaren eta Gobernantza Parte-hartzailearen Aurkako Borroka

Zaharreria —zahartzaroari buruzko estereotipo negatiboak— osasunean eta errendimenduan eragina duen oztopo bat da. Adineko helduen irudia sustatu behar dugu, bizitza osoan ikasteko ahalmena duten pertsona konpetente gisa.

6.1. Estereotipoen eta zaharreriaren eragina

"Estereotipoen mehatxuak" benetako gainbehera kognitiboa ekar dezake adineko helduek zahartzaroa ezgaitasunaren sinonimoa dela barneratzen badute. Erakundeek komunikazioak termino infantilizatzaileak saihestu behar ditu eta zahartze osasuntsuan irauten duen plastizitate kognitiboa azpimarratu.

6.2. Sexualitatea eta ongizate emozionala

Ezinbestekoa da zahartzaroa asexualitatearekin lotzen duten mitoak ezabatzea. Maitasuna eta sexualitatea norbanakoaren berezkoak dira bizitzaren amaierara arte eta osasun orokorraren adierazle nagusiak dira. Zaintza-zentroetan eta etxebizitzetan pribatutasuna errespetatzea gizarte-zerbitzuen betebeharra da.

6.3. Hamar gomendio gobernantza parte-hartzailerako

Kudeaketa publiko moderno eta eraginkorrerako, jarraibide hauek proposatzen dira:

Erabakiak hartzerakoan integratzea: Tokiko eta eskualdeko mailan adinekoen kontseilu lotesleak sortzea.

Zentroen kudeaketa: Erabiltzaileak animatzea beren gizarte-zentroak eta klubak kudeatzera ahaldundzea sustatzeko.

Adinaren aurkakotasuna kontrolatzea: Publizitatean eta komunikabideetan irudi diskriminatzaileak kontrolatzeko eta kontrolatzeko sistemak ezartzea.

Belaunaldien arteko programak: Eskoletan proiektuak ezartzea, non adinekoek ezagutza eta balioen tutore gisa jarduten duten.

Adinekoentzako ingurune egokiak: Hirigintza eta etxebizitza egokitu, zahartzea bertan eta mugikortasuna errazteko.

Bizitza osoan zehar ikaskuntza sustatzea: Adinekoentzako unibertsitateetarako sarbidea eta alfabetatze teknologikoa (IKT) erraztea.

Adinaren aurkako komunikazioa ez dena: Profesionalak eta komunikabideak trebatzea errespetuzko eta haurtzaroa ez den hizkuntza erabiltzen. Aniztasuna babestea: Ziurtatu politikek adinekoen aniztasun etnikoa, sexuala eta kulturala aitortzen dutela.

Ekonomia zibikoa sustatzea: Adinekoen boluntarioritza eta gizarte-parte-hartzea formalki babestea.

Haurtzarotik prebentzioa: Belaunaldi berriei hezteko zahartzea bizitza osoan zeharreko prozesua eta banakako erantzukizuna dela. Laburpen Exekutiboa: Gomendio Presagarriak

Autonomia Proaktiboki Sustatzea: Telelaguntza eta etxeko arreta zerbitzuen estaldura handitzea, zerbitzuaren ezagutzaren eta erabileraren arteko aldea txikituz.

Arreta Profesionalizatzea: Emakumeen zama bakarra arintzen duten eta etorkinen zaintza sektorea arautzen duten erantzukizun partekatuko politikak ezartzea.

Irudi Soziala Eraldatzea: Adinekoen balio ekonomikoa eta ikaskuntza gaitasuna nabarmentzen dituzten gobernu kanpainak abiaraztea.